

Myopathies inflammatoires : myosites

I. Introduction :

Les Myopathies Inflammatoires Idiopathiques MII (Myosites) :

- Maladies inflammatoires chroniques du muscle squelettique
- Rares et sévères
- Origine mal identifiée mais auto-immunité
- Traitements :
Non spécifiques
Pas toujours efficaces
Effets secondaires

II. Définition :

Les myopathies inflammatoires idiopathiques :

- Connectivites
- Maladies auto-immunes
- Font parties des myopathies acquises (non héréditaires)
- Touchent le muscle strié squelettique.
- Systémiques non spécifiques d'organes (atteintes musculaires et extra-musculaires)
- Rares et hétérogènes (troubles fonctionnels, survenue, durée, issue de la maladie et réponse aux traitements)

III. Intérêt de la question :

- Touche plus les femmes que les hommes (sexe ratio : 2/3)
- Rare : 6 à 7 personnes sur 100 000
- Touche principalement l'adulte (exceptionnelle chez l'enfant)
- Polymorphisme clinique
- Pronostic : peut être grave
- Le traitement est basé sur les corticoïdes...

IV. Classification :

- La polymyosite
- La dermatomyosite (DM)
- La myopathie nécrosante auto-immune (MNAi)
- La myosite à inclusions (MI)
- Le syndrome des anti-synthétases (SAS)

V. Diagnostic :

1. Caractères communs :

- Déficit musculaire :
 - D'installation progressive
 - Bilatéral et symétrique
 - Touchant les muscles proximaux « ceintures scapulaire et pelvienne »
SAUF pour les myosites à inclusions
- Apparition dans le muscle d'un infiltrat inflammatoire riche en cellules mononuclées

2. Polymyosite :

- Signes musculaires :
 - Myalgies
 - La force musculaire est diminuée.
 - Les muscles finissent par s'atrophier provoquant une invalidité.
 - L'atteinte des muscles pharyngolaryngés et respiratoires : signes de gravité +++
- Atteinte articulaire :
 - Polyarthralgies inflammatoires
 - Petites et moyennes articulation
 - Périphérique +++
 - Bilatérales et symétriques
 - Non déformantes et non destructrices

- Signes cutanés : DM
 - Papules de Gottron ou macules violacées, kératosiques si chroniques
 - Érythème des faces d'extension (MCP)
 - Érythème périunguéal (Signe de la manucure)
 - Signe du décolleté ou du châte
 - Photosensibilité
 - Erythème périorbitaire en lunette
 - (Erythro-)œdème lilacé des paupières
 - Vascularite nécrosante



3. La myosite à inclusions :

- La plus fréquente des MI après 50 ans
- Association de signes distaux et proximaux, asymétriques
- Troubles de la déglutition fréquents (50 %)
- Formes familiales
- Corticorésistance

4. Immunologie :

- Auto-Ac spécifiques des myosites
Anti-synthétases :
 - Anti-Jo1 (Muscle), anti-PL7 et anti-PL12 (ILD), anti-KS, anti-OJ, anti-EJ
- Myosites nécrosantes auto-immunes (MNAI)
 - Anti-SRP
 - Anti-HMGCR
 - Formes paranéoplasiques si pas d'AutoAc
- Dermatomyosites
 - Anti-Mi2 : pas de cancer, bonne réponse TT
 - Anti-MDA-5 : DM amyopathique, lésions cutanées nécrotiques et pulmonaires sévères, 46 % de mortalité à 6 mois
 - Anti-TIF1γ : DM nécrosante et très associée au cancer
 - Anti-SAE : DM et dysphagie++

5. EMG :

- Tracé de type myogène
- Pas d'anomalies nerveuses

6. IRM musculaire :

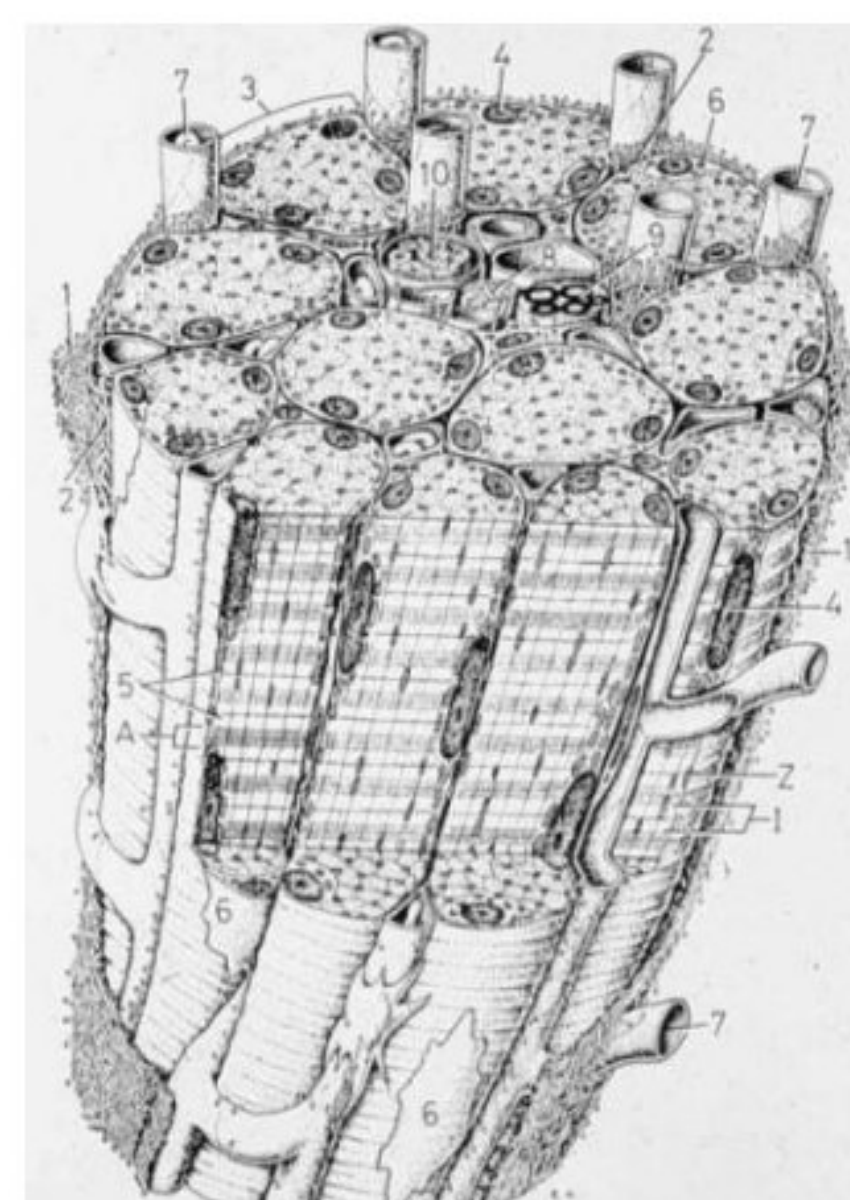
- Atrophie
- Infiltration graisseuse
- Inflammation

→ But :

- But diagnostique dans les cas atypiques
- Diriger la biopsie musculaire
- Signes d'activité

7. Biopsie musculaire :

- Signes de destruction :
 - Fibres de taille irrégulière, noyau centralisé
 - Nécrose, phagocytose
- Signes de régénération :
 - Petites fibres basophiles CD56 + (NCAM)
 - Infiltrat inflammatoire mononucléé



VI. Élément de classification : histopathologie

- Polymyosite :
 - Macrophages et Ly T CD8
 - Prédominant dans l'endomysium
 - Envahissant fibres saines HLA I+

- Dermatomyosite :
 - Ly B et T CD4+
 - Prédominant dans les régions périvasculaires
 - Anomalies vasculaires : raréfaction des capillaires et anomalies morphologiques
 - Atrophie perifasciculaire
- Myopathies nécrosantes auto-immunes :
 - Prédominance de la nécrose/régénération
 - Peu d'infiltrat inflammatoire, HLA I moins diffus
- Myosites à inclusions :
 - Association de vacuoles bordées à un infiltrat endomysial Ly T CD8

VII. Diagnostic de gravité :

- Atteinte des muscles
 - Pharyngolaryngés (dysphagie)
 - Respiratoire
 - Cardiaque

VIII. Diagnostics différentiels :

- Sclérodermies ;
- Sarcoïdose musculaire ;
- Dystrophie musculaire progressive ;
- Myasthénie ;
- Myopathies métaboliques...

IX. Traitement :

1. Corticothérapie :

- Reste la pierre angulaire du traitement
- 1 mg/kg/j 4 à 6 semaines puis décroissance progressive
- Mais effets secondaires fréquents
- Souvent insuffisante pour une rémission prolongée et de bonne qualité
- Inefficacité ou effets secondaires 44 %
- Rémission complète 17 à 28 %
- Rechutes 50-60 %

2. Immunosuppresseurs conventionnels :

- MTX, AZA, Ciclo : en 1ère ligne : 1 seul essai contrôlé AZA+Pred vs Pred
- Formes réfractaires :
 - Efficacité semblable MTX (7.5-15mg/semaine)
 - AZA (2.5 mg/kg/j)
 - Ciclo (3-3.5mg/kg/j)
- Avec un meilleur profil de tolérance pour le MTX
- Association MTX+AZA+Pred si échec (efficacité 53 %)

3. Immunosuppresseurs-alternatives :

- Cellcept 2 g/j si échec MTX ou AZA
 - Efficace sur le muscle et poumon
 - Attention aux infections opportunistes
- Arava
- Endoxan : Uniquement si ILD sévère et évolutive

4. Immunoglobulines intraveineuses :

- 2g/kg en cure mensuelle 3 à 6 mois
- Efficacité démontrée contre placebo dans les DM réfractaires aux corticoïdes
- Études ouvertes dans les PM réfractaires corticoïdes/IS
- En cas de troubles de la déglutition sévères et réfractaires
- CI aux immunosuppresseurs

